

Opór jako manifestacja lęku

Opór nie jest złą wolą ani cechą charakteru — to sygnał, że lęk przed afektem jest silniejszy niż motywacja. Nie problem do pokonania, lecz materiał do zrozumienia.

CZAS: 25 min **KAŻDY MOMENT OPORU:** spóźnienie, „nic się nie zmieniło”

ŹRÓDŁO: Davanloo (1990); Safran & Muran (2000)

JAK UŻYWAĆ

Traktujesz opór jako materiał, nie wroga. Rozpoznajesz go (spóźnienia, opuszczone sesje, „ostatnio było dobrze, może skończymy”, dyskusje zamiast doświadczenia, nagła „poprawa”), nazywasz go wspólnie bez oskarżania, pytasz o lęk pod spodem, walidujesz ten lęk i zapraszasz do wspólnego badania. Z oporem idziesz **jak z falą** — nazywasz, ciekawisz się, czekasz — zamiast naciskać.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Etykietowanie pacjenta („oporny”, „nieuczciwy”) eskaluje konflikt i niszczy sojusz. Klasyczne rozumienie (Freud): opór jest manifestacją nieświadomego lęku przed zmianą — pacjent świadomie chce zmiany, ale nieświadomie boi się jej, bo zmiana oznacza kontakt z zablokowanym afektem. Nierozpoznany opór niszczy terapię („dryf”); rozpoznany i nazwany staje się drogą do głębokiego afektu. Praca z oporem to 60–70% czasu STPP u pacjentów wysoko defensywnych i z somatyzacją (Abbass, 2015).

01 Sześć kroków pracy z oporem

- ① **Nie walcz** — im bardziej naciskasz, tym większy opór
- ② **Waliduj** — „zrozumiałe, że trudno tu wejść”
- ③ **Zauważ lęk za oporem** — opór to wierzchołek, lęk jest pod spodem
- ④ **Klaryfikuj** — przed czym opór chroni?
- ⑤ **Współpracuj** — „razem przyjrzymy się temu ruchowi”
- ⑥ **Stopniowa redukcja** — przez bezpieczeństwo, nie przez nacisk

02 Nazwij opór bez oskarżania

Oskarżenie („Pani ucieka od pracy”) tworzy pęknięcie. Ciekawość („widzę ruch odsuwania się — co pod tym jest?”) otwiera pracę. Zapisz wersję dla oporu, który widzisz u tego pacjenta.

JAK NAZWĘ TEN OPÓR

03 ☉ Pytaj o lęk pod spodem

„Czego się Pani obawia, gdyby weszła w ten temat?” Potem waliduj: „to normalne, że psychika chroni nas przed tym, co raniło. Opór ma sens.” Zapisz, czego dotyczy lęk.

LĘK UKRYTY POD OPOREM

04 ✨ Sprawdź, czy opór dotyczy relacji z Tobą

Często opór dotyczy lęku przed zależnością, kontrolą lub odrzuceniem — w relacji z terapeutą. Rozważ interpretację łączącą trzy sfery (terapeuta-obecne-przeszłe). Zapisz hipotezę.

CZY OPÓR JEST TEŻ WOBEC MNIE? HIPOTEZA

Klucz: gdy pacjent mówi „dziękuję, już mi lepiej, może skończymy” w 6. sesji terapii 20-sesyjnej — to najczęściej opór, nie prawdziwa poprawa. Realna poprawa przychodzi z refleksją, ambiwalencją i smutkiem, nie z nagłym optymizmem. Nazwij obserwację wspólnie: „ciekawi mnie ta zmiana — widzi Pani, co się dzieje?”